Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Jans Salinas Herrera				Sexo	F	M X
Fecha Nacimiento	5-2-2010	Edad actual	16 años	2 meses	País natal:	Chile	
Domicilio actual:	Los copihues block 1470 D 112				Teléfono	75624833	
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende ☒ habla ☒ lee ☒ escribe ☒				
Lengua de uso	Español	Grado dominio	comprende ☒ habla ☒ lee ☒ escribe ☒				
Escolaridad actual:	8°B.	Establecimiento	Liceo Mixto Básica 1.				

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 14-04-2026	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Nataly Herrera L.	Nombre:
Relación con el/la estudiante: Madre.	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista: 14-04-2026	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Marta Fernández C.	Nombre:
Rol/cargo: Coor. PIE Pod.	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

Postulación e ingreso al Programa.

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☒ Sí (especificar)	
Pediatría:	Psicología:
Kinesiología:	Psiquiatría:
Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología:	Terapia Ocupacional:
Neurología: TDAH	Otro:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: ☑ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☐ cesárea (señalar motivo)

Tuvo asistencia médica durante el parto? ☐ SI ☐ NO | Peso: 3.350. | Talla: 52 cm.

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:

normal en gral.

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Sí	~~No~~	Traumatismos	Sí	~~No~~	Encefalitis	Sí	~~No~~
Obesidad	~~Sí~~	No	Intoxicación	Sí	~~No~~	Meningitis	Sí	~~No~~
Fiebre alta	~~Sí~~	No	Enfermedad respiratoria	~~Sí~~	No	Otra(s)		
Convulsiones	~~Sí~~	No	Asma	Sí	~~No~~			
Hospitalizaciones	~~Sí~~	No	Especifique motivos y duración: 12 Hospi. Neumonía.					

Se realizaron controles periódicos de salud: ~~Sí~~ No | Vacunas: ~~Sí~~ No

Observaciones:

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza:	6 m.	Se sienta sólo/a:	6 m	Camina sin apoyo:	1 a 3 m.
Primeras palabras:	7 m.	Primeras frases:	1 a 4 m.	Se viste solo/a:	4 a.

Controla esfínter vesical — Diurno: ✓ Nocturno: ✓

Controla esfínter anal — Diurno: ✓ Nocturno: ✓

Observaciones:

le costó controlar esfinter vesical. hasta los 5 años (nocturno) a los 7. logró.

En su actividad motora general se aprecia: ☑ normal ☐ activo ☐ hiperactivo ☐ hipoactivo

Su tono muscular general se aprecia: ☐ normal ☑ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	Sí	~~No~~	Caídas frecuentes	~~Sí~~	No	Dominancia lateral	~~Sí~~	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	~~Sí~~	No	Prensión	~~Sí~~	No	Pinza	~~Sí~~	No
Ensarta	~~Sí~~	No	Dibuja	~~Sí~~	No	Escribe	~~Sí~~	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	~~Sí~~	No	Manipula y Explora objetos	~~Sí~~	No
Demanda objetos y compañía	~~Sí~~	No	Comprende prohibiciones	~~Sí~~	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	~~Sí~~	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Si	~~No~~

Observaciones:

Escoliosis (usa plantillas) ha sufrido caídas.

-le cuesta el uso de tijeras.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.3. Visión - Audición:

Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	Sí	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	Sí	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	No	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	Sí	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	No	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	Sí	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí	No	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	No
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	Sí	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Sí	No
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	No	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	No
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	No	La pronunciación oral es adecuada	Sí	No
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	No	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	No

Observaciones:
Choca producto de la escoliosis.

5.4. Desarrollo del Lenguaje

El niño (a) se comunica preferentemente en forma
☐ oral ☐ gestual ☒ mixto ☐ otro (especifique):

Características del lenguaje expresivo

Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	Sí	No	Emite/produce frases	Sí	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	Sí	No	Relata experiencias	Sí	No
Emite palabras/produce señas	Sí	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí	No

Características del lenguaje comprensivo

Identifica objetos	Sí	No	Sigue instrucciones simples	Sí	No
Identifica personas	Sí	No	Sigue instrucciones complejas	Sí	No
Comprende conceptos abstractos	Sí	No	Sigue instrucciones grupales	Sí	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	Sí	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	Sí	No

Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos):

Observaciones: le cuesta comprender lo que lee.

3

5.5. Desarrollo Social

Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	Sí	No	Se relaciona en forma colaborativa	Sí	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	Sí	No	Respeta normas sociales	Sí	No
Participa en actividades grupales	Sí	No	Respeta normas escolares	Sí	No
Opta por trabajo individual	Sí	No	Muestra sentido del humor	Sí	No
Presenta lenguaje ecolálico	Sí	No	Movimientos estereotipados	Sí	No
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	Sí	No	Pataletas frecuentes	Sí	No

Ante los siguientes estímulos su reacción es:

Luces:	**Sonidos:**	**Personas extrañas:**
☒ natural ☐ desmesurada	☒ natural ☐ desmesurada	☒ natural ☐ desmesurada

Observaciones:
le cuesta socializar. (tímido) Presenta Onicofagia.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante

Vacunas al día	Sí	No	Trastorno motor	Sí	No
Epilepsia	Sí	No	Problema bronco-respiratorio	Sí	No
Problemas cardiacos	Sí	No	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	No
Paraplejia	Sí	No	Trastorno emocional	Sí	No
Pérdida auditiva	Sí	No	Trastorno conductual	Sí	No
Pérdida visual	Sí	No	Otro (especifique):		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique):

Neumonia (Hosp).

Alimentación: ☑ normal ☐ "malo/a" para comer ☐ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)

Peso (apreciación del informante): ☑ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad

Sueño: ☐ normal ☐ tranquilo ☑ inquieto **Horas** que duerme: 9 hr. aprox

☐ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos
☐ sonambulismo ☑ despierta de buen humor

Duerme: ☑ solo ☐ acompañado
(Especifique):

Humor/comportamiento ***(señale el comportamiento habitual)***

☑ alegre ☑ juguetón/bromista ☐ risueño(a) ☐ triste ☑ serio ☐ rebelde ☑ apático ☐ violento(a)
Otro:

Observaciones:

Se nota más serio la madre indica que podría ser la etapa del niño.

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.

Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Juan Urbina A.	Padre NB	48	4ºm	Gasfiter.
2. Nataly Herrera	Madre	39	3ºm	Dueña de Casa
3. Catalina Muñoz	Hermana	23	Uni.	Enfermera
4. Boris Muñoz.	Hermano	19	4ºm.	Estudiante.
5. Javier Urbina	Hermano	13	8vo.	Estudiante.
6.				
7.				
8.				

Antecedentes de Salud de la Familia

(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):

Es el unico que presenta TDAH.

Observaciones:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar

Edad de ingreso al sistema escolar	4a	Asistió a jardín infantil	☑ Sí	No
Nº de colegios en que ha estudiado	3	Modalidad de enseñanza Regular ☑ Especial ☐ Técnica ☐:		

Motivo de los cambios:
Por comportamiento.

Ha repetido curso/s	Sí	No	Curso(s)	Motivo:
	☑			1° y 4°; 8° no sabía leer.

Situación actual

Nivel/curso actual	8vo		**Dificultad de aprendizaje**	Sí ☑	No	**Dificultad para participar**	Sí ☑	No	**Conducta disruptiva**	Sí ☑	No
Asiste regularmente	Sí ☑	No	Asiste con agrado	Sí ☑	No	Apoyo familiar en tareas	Sí ☑	No	Amigos (as)	Sí ☑	No

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?
☑ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?
☑ apoyo ☑ castigo ☐ indiferencia ☐ compasión ☑ tensión ☐ otra .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?
☑ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra .....
Especifique el tipo de refuerzos o premios:
☐ expresiones afectivas ☑ alimentos preferidos ☑ ver TV ☐ juguetes ☐ tiempo libre ☐ otro(s).....

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?
☑ madre ☑ padre ☑ hermanos/as ☐ Otros familiares ☐ Otros profesionales .....

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?
☑ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?
☑ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:
En tercero básico recibió una dosis muy alta incapacitante.
Contacto whatsapp 993856637.

5

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY